

CAPÍTULO 13.35

Trombosis Venosa Profunda

PERFIL EUNACOM 1.01.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El manejo del **Tromboembolismo Pulmonar (TEP)** y de la **Trombosis Venosa Profunda (TVP)**, englobados en la enfermedad tromboembólica venosa, es un tema de alta rentabilidad en el examen EUNACOM. Más allá de los algoritmos diagnósticos estándar, existen "detalles finos" y situaciones especiales que definen la conducta terapéutica correcta.

A continuación, analizamos 5 puntos clave y consideraciones críticas en el manejo de estas patologías.

1. Contraindicaciones de la Anticoagulación y el Filtro de Vena Cava

La base del tratamiento tanto del TEP como de la **TVP** es la anticoagulación. Sin embargo, en la práctica clínica nos enfrentamos frecuentemente a pacientes con un riesgo hemorrágico prohibitivo.

Cuando existe una **contraindicación absoluta para anticoagular**, no se puede dejar al paciente sin protección, dado el alto riesgo de mortalidad por un nuevo evento embólico. En este escenario, el procedimiento de elección es la instalación de un **Filtro de Vena Cava Inferior (FVCI)**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Principales contraindicaciones para iniciar anticoagulación: - **Hemorragia digestiva activa** (alta o baja). - **Accidente Cerebrovascular (ACV) hemorrágico** reciente. - **Politraumatismo reciente:** El daño endotelial y la inmovilidad aumentan el riesgo de TEP, pero el riesgo de hemorragia interna impide el uso de heparinas o TACO. - Cirugía mayor reciente (especialmente neurocirugía o cirugía oftalmológica).

NOTA CLÍNICA

El filtro de vena cava actúa mecánicamente atrapando los émbolos que se desprenden de las extremidades inferiores antes de que lleguen a la circulación pulmonar. Es una medida de rescate que no trata el trombo original, sino que previene la complicación mortal.

2. Manejo del TEP Masivo con Contraindicación de Trombolisis

El **TEP Masivo** se define por la presencia de **inestabilidad hemodinámica** (shock obstructivo o hipotensión sostenida). En estos casos, el tratamiento de elección es la **trombolisis sistémica** para disolver rápidamente el coágulo.

Sin embargo, si el paciente tiene contraindicaciones para la trombolisis (que suelen ser las mismas que para la anticoagulación, pero con criterios más estrictos), se debe optar por un manejo invasivo: la **Embolectomía de la Arteria Pulmonar**.

TABLA 13.35.1: ESCENARIO CLÍNICO VS CONDUCTA DE ELECCIÓN

ESCENARIO CLÍNICO	CONDUCTA DE ELECCIÓN	ALTERNATIVA (SI HAY CONTRAINDICACIÓN)
TEP Estable	Anticoagulación (Heparina/ACOD)	Filtro de Vena Cava Inferior
TEP Masivo (Shock)	Trombolisis Sistémica	Embolectomía (Quirúrgica o Percutánea)

3. Tratamiento Empírico: ¿Esperar el examen o actuar?

Una duda frecuente es si se debe esperar la confirmación diagnóstica (AngioTAC o Ecografía Doppler) para iniciar el tratamiento.

La regla de oro es: **Ante una sospecha clínica moderada o alta, se debe iniciar la anticoagulación de inmediato**, a menos que existan contraindicaciones. Es preferible anticoagular a un paciente que finalmente no tiene un TEP, que permitir que un paciente con TEP sufra

una recurrencia masiva o fallezca mientras espera el turno del radiólogo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si te presentan un paciente con alta probabilidad clínica (según Score de Wells) y el examen confirmatorio va a demorar, la respuesta correcta suele ser **iniciar Heparina de inmediato**.

4. El Valor del AngioTAC y la Cintigrafía V/Q en la Actualidad

El estudio de imágenes ha evolucionado significativamente, desplazando técnicas que antes eran el estándar.

El AngioTAC como "Gold Standard"

En la actualidad, si un **AngioTAC de tórax es informado como normal**, se considera que el TEP queda **descartado**, incluso si la sospecha clínica previa era muy alta. Gracias a la tecnología multidetector y al entrenamiento de los radiólogos modernos, su valor predictivo negativo es extremadamente alto. Si el AngioTAC es negativo, el médico debe proceder a buscar diagnósticos diferenciales.

La Cintigrafía de Ventilación/Perfusión (V/Q)

Este examen, muy utilizado hace décadas, ha quedado prácticamente **obsoleto** en la práctica diaria. - **¿Cuándo se usa?:** Solo en casos donde el AngioTAC está contraindicado (principalmente insuficiencia renal severa o alergia grave al contraste) y el centro cuenta con el recurso. - **Realidad clínica:** Generalmente, los centros que no disponen de AngioTAC tampoco disponen de medicina nuclear para realizar una cintigrafía V/Q.

5. Dos Preguntas Críticas Antes del Manejo

Antes de definir el tratamiento de cualquier paciente con sospecha de TEP, siempre debemos responder dos preguntas fundamentales:

- **¿Está contraindicada la anticoagulación?:** Esta pregunta debe hacerse de forma proactiva (buscar antecedentes de sangrado, cirugías recientes o trauma).
- **¿Cuál es el estado hemodinámico?:** Determinar si es un TEP masivo o no masivo cambia radicalmente el algoritmo. El TEP masivo requiere una unidad de cuidados críticos, monitorización invasiva y, potencialmente, trombolisis o cirugía de urgencia.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Resumen de perlas para el examen: - **Signo de S1Q3T3:** Es clásico pero poco sensible (solo presente en un 20% de los TEP). - **Taquicardia sinusal:** Es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en el TEP. - **Dímero D:** Solo sirve para **descartar** TEP en pacientes con probabilidad clínica **baja**. Si el Dímero D es positivo o la sospecha es alta, siempre se requiere imagen.

Resumen de Decisiones Terapéuticas

- **Sospecha alta + Inestabilidad:** Considerar TEP masivo $\rightarrow$ Ecocardiograma al pie de la cama (buscando signos de falla VD) o AngioTAC si es posible trasladar $\rightarrow$ Trombolisis.
- **Sospecha alta + Estabilidad:** Iniciar anticoagulación $\rightarrow$ Confirmar con AngioTAC.
- **Confirmado + Contraindicación de anticoagulación:** Filtro de Vena Cava.
- **Confirmado + Shock + Contraindicación de trombolisis:** Embolectomía.

Para profundizar en la evaluación inicial, te recomendamos revisar los artículos sobre **Insuficiencia Cardíaca: Generalidades** y **Shock: Enfoque Inicial**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 45 años, postoperada de cirugía de cadera hace 5 días, consulta por dolor y aumento de volumen en pierna izquierda de inicio hace 24 horas. Al examen: edema blando, signo de la fóvea positivo, cianosis leve. Score de Wells 4 puntos. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trombosis Venosa Profunda. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La TVP se produce por la tríada de Virchow: hipercoagulabilidad, estasis venosa y daño endotelial
- La clínica es unilateral con dolor, edema blando y cambios de coloración en la pierna
- Los principales diagnósticos diferenciales son quiste de Baker roto y celulitis
- El diagnóstico confirmatorio se realiza con eco-Doppler de extremidades inferiores
- El dímero D solo se usa con baja sospecha (Wells < 3); menor a 500 pg/mL descarta TVP
- El tratamiento es anticoagulación por mínimo 3 meses (HBPM, HNF o NACOs)
- Toda TVP debe estudiarse con panel de trombofilia para definir anticoagulación permanente
- La flegmasia cerúlea dolens es la única indicación de trombólisis o trombectomía en TVP

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA)

PREGUNTA 1

Paciente de 45 años, postoperada de cirugía de cadera hace 5 días, consulta por dolor y aumento de volumen en pierna izquierda de inicio hace 24 horas. Al examen: edema blando, signo de la fóvea positivo, cianosis leve. Score de Wells 4 puntos. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?

- A)** Solicitar dímero D y esperar resultado
- B)** Realizar eco-Doppler de extremidades inferiores
- C)** Solicitar angioTAC de tórax
- D)** Iniciar anticoagulación empírica sin estudio
- E)** Solicitar radiografía de extremidades inferiores

PREGUNTA 2

Mujer de 32 años consulta por dolor en pantorrilla derecha y leve edema. Sin antecedentes de cirugía ni inmovilización reciente. Score de Wells 1 punto. Se solicita dímero D que resulta 280 pg/mL. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Solicitar eco-Doppler venoso de extremidades inferiores
- B)** Iniciar heparina de bajo peso molecular de inmediato
- C)** Descartar TVP y buscar diagnóstico alternativo
- D)** Solicitar angioTAC de tórax para descartar TEP
- E)** Solicitar estudio de trombofilia

PREGUNTA 3

Paciente de 50 años con TVP iliofemoral masiva izquierda que evoluciona con cianosis intensa, edema severo y ausencia de pulsos distales en la extremidad afectada. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta terapéutica más adecuada?

- A)** TVP complicada; mantener anticoagulación con heparina solamente
- B)** Flegmasia cerúlea dolens; trombólisis intravenosa y eventual trombectomía
- C)** Síndrome compartimental; fasciotomía de urgencia
- D)** Insuficiencia arterial aguda; embolectomía arterial de urgencia
- E)** Celulitis necrotizante; antibióticos de amplio espectro y cirugía

RESUMEN: TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

La trombosis venosa profunda (TVP) es una patología frecuente causada por la tríada de Virchow: hipercoagulabilidad, estasis venosa y daño endotelial. Entre las causas de hipercoagulabilidad se encuentran las trombofilias congénitas (déficit de antitrombina III, proteína S, proteína C) y adquiridas (síndrome nefrótico, cáncer, síndrome antifosfolípido, embarazo, puerperio). La estasis venosa se observa en pacientes postrados o posquirúrgicos, y el daño endotelial en traumatismos. La clínica es habitualmente unilateral, con dolor en la cara posterior de la pierna, edema blando con signo de la fóvea positivo y cambios de coloración (cianosis o eritema). Los diagnósticos diferenciales incluyen el quiste de Baker roto y la celulitis. En el examen físico puede encontrarse el signo de Homans (dolor con dorsiflexión del pie), empastamiento muscular y palpación del cordón venoso profundo. Es importante distinguir la TVP de la tromboflebitis superficial. El diagnóstico se confirma con eco-Doppler de extremidades inferiores. El dímero D solo es útil con baja sospecha clínica (score de Wells menor a 3) y sin otras causas que lo eleven; si es menor a 500 pg/mL descarta TVP, si está elevado obliga a confirmar con eco-Doppler. Toda TVP requiere estudio de trombofilia posterior para definir duración de anticoagulación. El tratamiento consiste en anticoagulación (heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada o NACOs) más reposo relativo. La duración mínima es de 3 meses, pudiendo extenderse a 6 meses o de forma permanente si se demuestra trombofilia. En embarazadas se prefiere HBPM. La trombólisis y trombectomía solo se indican en la flegmasía cerúlea dolens, complicación masiva con vasoespasma arterial y riesgo de isquemia de la extremidad.